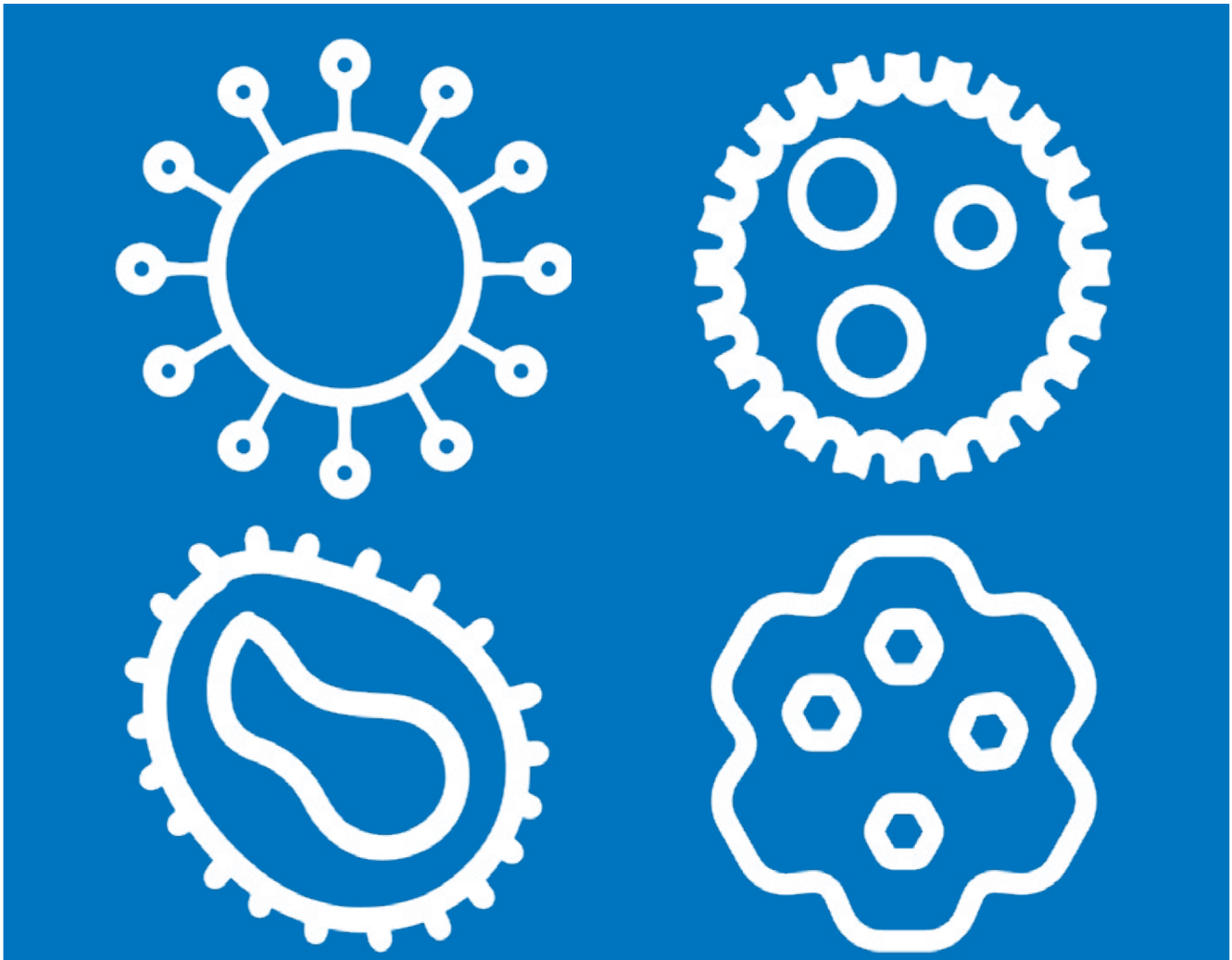
Diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)

Gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) soa 2024



*De **MDR soa app** heeft meer informatie, zoals adviezen over overdraagbaarheid na behandeling en management van sekspartners*

SOAIDS Nederland

Deze samenvattingskaart van de MDR soa richt zich op volwassenen (immuuncompetent en waar nodig ook immuungecompromitteerd, soms ook zwangeren). Voor alle andere situaties (specifiek neonaten/kinderen/alternatieve behandelingen en afkortingen): raadpleeg de volledige tekst van de richtlijn. **De MDR soa app heeft meer informatie**, zoals adviezen over overdraagbaarheid na behandeling en management van sekspartners en afkortingen.
Waar ♂ staat kan 'persoon met penis' gelezen worden, waar ♀ staat kan 'persoon met vagina' gelezen worden.

Soa-gerelateerde syndromen

Syndroom (verwekker)	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Urethritis (Ct/Ng/Tv/Mg) *Incubatietijd afhankelijk van verwekker*	Dysurie, irritatie van de urethra en/of jeuk icm afscheiding uit de urethra of leukocyturie in de eerstestraalsurine	Lichamelijk onderzoek: - inspectie genitalia, afscheiding (helder/purulent) - palpatie scrotum en liezen bij vermoeden epididymitis - temperatuur meten Aanvullend onderzoek: - Urethritis zonder afscheiding: • eerstestraalsurine (voorkeur ochtendurine) • bepaal leukocyten in sediment of leukocyten esterase test (stick) - Indien leukocyturie of afscheiding: • Diagnostiek (NAAT) naar Ct en Ng. Indien mogelijk sneldiagnostiek Ng mbv methyleenblauwkleuring of gramkleuring. • Op indicatie (sekstechnieken en bij specifieke klachten): afname diagnostiek op andere plaatsen (keel, rectum, conjunctiva)	Wacht bij voorkeur de uitslag van aanvullend onderzoek af en behandel volgens testuitslag Indien test op Ct en Ng negatief: wacht 4 w spontaan herstel af Indien vanwege ernst van de klachten of andere redenen uitslag van aanvullend onderzoek niet kan worden afgewacht: - start direct na afname van materiaal voor aanvullend onderzoek een behandeling tegen Ct (zie specifieke verwekker); EN/OF - start behandeling tegen Ng bij een hoge kans op gonorroe, zoals bij purulente afscheiding uit de penis of contact met sekspartner met bewezen gonorroe (klachten ontstaan meestal 2 - 6 d na seksueel contact) (zie specifieke verwekker)	**Controle:** aanhoudende klachten na behandeling opnieuw evaluatie: - is behandeling afgemaakt? - kan er sprake zijn van herinfectie of een nieuwe infectie? - overweeg Mg en Tv diagnostiek en zn behandeling bij geen spontaan herstel binnen 4 w (bij urethritis negatief voor Ct en Ng) of bij persisterende klachten ondanks adequate behandeling **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker Geen verwekker aangetoond: geen sekspartners inlichten Adviseer geen seks totdat klachten verdwenen zijn en in elk geval tot 7 d na start behandeling
Proctitis (Ng/Ct incl. LGV/syfilis/ mpox/HSV) *Incubatietijd afhankelijk van verwekker* NB: bij verdenking mpox, zie LCI richtlijn	Ontsteking van het rectum: jeuk, pijn, krampen, obstipatie en afscheiding in en rond anus DD: inflammatory bowel disease (IBD), gevolg radiotherapie, corpora aliena, langdurig gebruik laxantia/klysmata/ anaal spoelen	Lichamelijk onderzoek: rectaal toucher, inspectie en palpatie van buik en liezen en inspectie van perianale regio Aanvullend onderzoek: - proctoscopie (zo nodig uit te breiden met sigmoïdoscopie) - grampreparaat - NAAT rectale swab Ct en Ng (eventueel kweek Ng, met name bij exsudaat) - TPPA ter uitsluiting van syfilis - donkerveldmicroscopie: spirocheten - bij ulcera en erosies: NAAT HSV, chlamydia (LGV) en syfilis van laesionale uitstrijk en op indicatie een biopsie PM: - bij Ct pos in MSM: NAAT LGV - bij hiv pos: diagnostiek naar hepatitis C - bij MSM met systemische klachten en pustels, ulcera perianaal, perioraal en/of peri-genitaal denk aan Mpox, zie ook specifieke verwekker - indien geen infectieuze oorzaak: doorverwijzen naar MDL-arts voor diagnostiek en uitsluiten inflammatoire aandoeningen	Verdenking symptomatische rectale chlamydia/LGV-proctitis (eventueel na uitsluiten Ng middels lichtmicroscopisch onderzoek): - doxycycline 100 mg po 2 dd 7 d - expectatief beleid (in afwachting van NAAT-uitslag, op geleide van de ernst van de klachten en in overleg met de patiënt) Verdenking symptomatische Ng-proctitis (al dan niet icm positief Ng proctitis (al dan niet icm positief grampreparaat, intracellulaire diplokokken): - ceftriaxon 500 mg im eenmalig - expectatief beleid (in afwachting van NAAT-uitslag, op geleide van de ernst van de klachten en in overleg met de patiënt) (in geval van een soa: zie behandeladviezen bij specifieke verwekker)	**Controle:** zie adviezen bij specifieke verwekker Bij MSM met een bewezen Ct- en /of Ng-proctitis is de kans op hiv-seroconversie verhoogd. Bespreek het seksuele gedrag, inventariseer de kans op hiv en adviseer op indicatie om te starten met PrEP **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker Geen verwekker aangetoond: geen sekspartners inlichten Adviseer geen seks totdat klachten verdwenen zijn en in elk geval tot 7 d na start behandeling
Acute epididymitis (soa opstijgend uit urethra, uropathogenen uit urinewegen) *Incubatietijd onbekend*	Veelal (sub)acuut optredende (< 6 w), eenzijdige scrotale pijn en zwelling Mogelijk dysurie, toegenomen mictiefrequentie, koorts, malaise Cave torsio testis (per acuut begin): spoedconsult uroloog	Lichamelijk onderzoek: malaise, temperatuur, inspectie genitaliën, afscheiding (purulent of helder), palpatie scrotum, liezen Epididymis is dik, vast en zeer gevoelig Aanvullend onderzoek: - Nitriettest, leukocyten test - urinekweek met resistentie bepaling of dipslide (indien positief: resistentie bepaling) - NAAT Ct tenzij andere diagnose op voorhand meer waarschijnlijk - indien risico of verdenking op gonorroe: ook NAAT Ng - bij twijfel over diagnose: echo scrotum	levofloxacine 500 mg po 1 dd 14 d OF ofloxacine 400 mg po 2 dd 14 d Contra-indicatie chinolonen: - meest waarschijnlijk UWI: cotrimoxazol 960 mg po 2 dd 14 d - meest waarschijnlijk soa: doxycycline 100 mg po 2 dd 14 d Indien verhoogd risico gonorroe: tevens behandeling Ng	**Controle:** - Klachten moeten verbeteren binnen 72 uur - Na 1 w uitslagen bespreken, evt behandeling aanpassen. - Opnieuw evaluatie indien persisterende klachten na 4 w **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker Geen verwekker aangetoond: geen sekspartners inlichten Adviseer geen seks totdat klachten verdwenen zijn, in elk geval tot einde antibiotische therapie

Syndroom (verwekker)	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Balanitis (infectieuze en niet-infectieuze oorzaken; zie bij symptomatologie) *Incubatietijd afhankelijk van oorzaak*	Ontsteking van glans penis en voorhuid, acuut of chronisch - Acuut: infectie met groep A en B streptokokken, candida albicans, gardnerella vaginalis, soa - Niet-infectieus: allergie, irritatie, trauma - Chronisch: vaak geen specifieke oorzaak	Lichamelijk onderzoek: - Acuut: erytheem, zwelling, erosies, (pussende) afscheiding, foetor, fimose - Chronisch: erytheem, papels, schilfering, erosies, rhagaden, atrofie, fimose Aanvullend onderzoek: Indien acute balanitis met pus/erosies/ulcera: soa uitsluiten, evt. KOH preparaat, gistkweek en/of banale kweek Bij twijfel over diagnose evt aanvullend histopathologisch onderzoek Bij recidief en ongewone presentatie: uitsluiten onderliggende oorzaken immuunsuppressie	Bij verminderde hygiëne: wassen met ruim lauw water of fysiologisch zout opl (géén zeep) Candida: - miconazolcrème 2%, 1-2 dd (met 1% hydrocortison bij inflammatie) tot de klachten weg zijn - bij therapieresistente gevallen/bij diabetes te overwegen: fluconazol 150 mg po eenmalig Behandeling (an)aerobe infecties: zie MDR app of richtlijn (in geval van een soa: zie behandeladviezen bij specifieke verwekker)	Niet-infectieuze oorzaken: verwijzing naar dermatoloog **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker
Genitale ulcera en inguinale lymfadenitis (syfilis, genitale herpes, LGV, mpox, chancroïd, granuloma inguinale) *Incubatietijd afhankelijk van verwekker*	Genitale ulcera: defecten, erosies, rhagaden in de huid en slijmvliezen in en rond de genitaliën en anus Inguinale lymfadenitis: pijnlijke, gezwollen lymfeklieren in de lies	Lichamelijk onderzoek: inspectie anogenitale gebied en mond op defecten, erosies, rhagaden inspectie hele huid: roseolen (syfilis stadium 2), schietschijf laesies (erythema exsudativum multiforme) Aanvullend onderzoek (zorg voor schoon ulcus): - Directe diagnostiek syfilis middels donkerveldmicroscopie - NAAT ulcusuitstrijk op herpes en Tp (op indicatie op H ducreyi en Ct genovar LGV) - uitsluiten syfilis middels serologie - Hiv-test met vierdegeneratie-ELISA-test - bij verdenking mpox: NAAT op MPXv op lesionale, orale en anale swabs - evt aspiratie pus op NAAT Ct en Ng	In geval van een soa: zie behandeladviezen bij specifieke verwekker Donovanosis (granuloma inguinale): zie Europese richtlijn (O'Farrel, 2016) Chancroïd: zie Europese richtlijn (Lautenschlager, 2017)	**Controle:** herhalen syfilis serologie na 3, 6 en 12 w Bij negatieve uitslag hiv, test herhalen na 12 w (gerekend vanaf moment ontstaan ulcus) of indien klachten bij een acute hiv-infectie optreden Bij verdenking import-soa, LGV of dermatologische niet-infectieuze oorzaak: verwijzing soa-deskundig dermatoloog **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker Adviseer geen seks totdat klachten verdwenen zijn, in elk geval tot einde antibiotische therapie
PID (soa opstijgend uit urethra, uropathogenen uit urinewegen) *Incubatieperiode onbekend*	Overweeg diagnose PID bij patiënten met een vagina met pijn onder in de buik (bilateraal bij lopen) en een van de volgende symptomen: - malaise en/of koorts (temperatuur >38 °C) - fluorklachten - abnormale vaginale bloedingen (intermenstrueel en of postcoïtaal) - diepe dyspareunie Verwijs naar de gynaecoloog bij: - ernstig algemeen ziek zijn (cave tubo-ovarieel abces). Bij koorts dient een abces te worden uitgesloten - zwangerschap - diagnostische twijfel, in het bijzonder over beoordeling van het vaginaal toucher, en immuungecompromitteerde personen	Lichamelijk onderzoek: mate van ziek zijn, temperatuur, palpatie abdomen, vaginaal toucher, speculumonderzoek Aanvullend onderzoek: - ALTIJD urine dipstick en zwangerschapstest (uitsluiten EUG!) - NAAT Ct en Ng (cervixuitstrijk) en kweek met zn resistentiebepaling Ng - lab: CRP, leuko's - lab serologie infectieziekten: hiv, hepatitis, syfilis - transvaginale echo door gynaecoloog - twijfel diagnose: CT of MRI - gouden standaard PID: laparoscopie	Klinische behandeling bij ernstig ziek zijn of een bewezen TOA Poliklinische behandeling: - levofloxacine 500 mg po 2 dd 14 d EN - metronidazol 500 mg po 2 dd 14 d EN - ceftriaxon 500 mg im, eenmalig (bij hoog risico op, hoge verdenking van of bewezen Ng-infectie) Klinische behandeling: - levofloxacine 500 mg 2 dd po 14 d EN - metronidazol 500 mg po of iv, 2 dd 14 d EN - ceftriaxon 2 g iv 1 dd tot Ng is uitgesloten Zie MDR voor behandeling bij zwangerschap/lactatie en alternatieve behandelingen	**Controle:** overleg of verwijzing gynaecoloog bij: ernstig ziek zijn, onvoldoende effect behandeling, immuungecompromitteerd, zwangerschap, diagnostische twijfel - Poliklinisch: na 2-3 d evaluatie effect behandeling - Klinisch: bij verbetering na 24 u parenterale therapie naar oraal. Bij verslechtering: opnieuw evaluatie. Bij gelijkblijvend beeld: na 72 u opnieuw evaluatie. **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker Geen verwekker aangetoond: geen sekspartners inlichten Adviseer geen seks totdat klachten verdwenen zijn, in elk geval tot einde antibiotische therapie

Syndroom (verwekker)	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Fluor vaginalis en vaginitis (Candida albicans, BV, Tv, Groep A-streptokokken-infecties (GAS), Ct, Ng) *Incubatietijd afhankelijk van oorzaak, zie specifieke verwekker*	Vaginale afscheiding: volgens patiënt afwijkend van gebruikelijke samenstelling wat betreft hoeveelheid, kleur, geur, al dan niet gepaard met jeuk en/of irritatie - Candida: jeuk, witte, brokkelige, niet-riekende afscheiding, rode/gezwollen vulva/vaginawand - BV: riekende, dunne, homogene fluor - Tv: jeuk, onaangename geur fluor, purulente afscheiding met belletjes, opgezwollen en rode cervix met witte stippen - Ct/Ng: zie aldaar	Lichamelijk onderzoek: - inspectie vulva en speculumonderzoek - indien verdenking opstijgende infectie: zie bij PID - LO kan achterwege blijven bij klachten identiek aan eerder aangetoonde candida of BV Aanvullend onderzoek: - overbodig bij waarschijnlijk candida of recidief BV - alle andere gevallen: pH fluor & aminetest - indien 3 positieve Amselcriteria: BV Zo niet, gericht vervolgonderzoek: • Microscopisch onderzoek (fysiologisch zoutpreparaat, KOH preparaat) • Gistkweek • Nugentscore (labonderzoek) • Specifieke kweek of NAAT Tv • NAAT Ct/Ng (sterk aan te bevelen in seksueel actieve populatie) Evaluatie diagnostiek: - Candida: positieve gistkweek, KOH-preparaat met schimmeldraden - BV: ≥3 positieve Amselcriteria óf ≥7 Nugentscore, positieve NAAT - Tv: positieve NAAT of kweek of trichomonaden bij lichtmicroscopie Amselcriteria: dunne homogene fluor, pH fluor > 4.5, positieve aminetest, 'clue'-cellen in fysiologisch zoutpreparaat	Candida: clotrimazol 200 mg vaginaaltablet an diep vaginaal inbrengen 3 d Bij keuze voor orale behandeling: fluconazol 150 mg po eenmalig BV: metronidazol 500 mg ovule, 1 dd 1 ovule an diep vaginaal inbrengen gedurende 7 dagen; tot 48 uur na (laatste keer) inbrengen mag geen alcohol worden gedronken OF metronidazol 500 mg 2 dd 1 po 7d OF 2000 mg stat po (niet zwangeren) Tv: metronidazol 500 mg po 2 dd 1 tablet 7 d Ct en Ng: zie aldaar Bij zwangerschap, lactatie, recidieven, profylaxe en voor overige alternatieve behandelingen, zie MDR	**Controle:** bij aanhoudende klachten: afspraak na 2 w Verricht zo nodig diagnostiek naar Ct, Ng en/of Tv (mits dit nog niet is uitgesloten) Overweeg consultatie van een arts-microbioloog bij non-albicans candida vaginitis Verwijs naar gynaecoloog bij aanhoudende klachten van fluor/ jeuk, onvoldoende effect behandeling, of als er aanwijzingen zijn dat er een andere oorzaak is voor de klachten die de zorgverlener niet zelf kan behandelen. **Partnernotificatie:** zie adviezen bij specifieke verwekker Niet zinvol bij BV en candida

Specifieke soa's

Soa & windowfase	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Chlamydiasis *(Chlamydia trachomatis Ct)* *1 - 3 w*	Vaak asymptomatisch ♀: pijnlijke of branderige mictie, veranderde fluor, contactbloedingen, bloedverlies tussen menstruaties, onderbuikspijn, proctitis Let op: EUG ♂: urethritis, proctitis Complicaties ♀: PID/tubo-ovariëel abces, verminderde vruchtbaarheid ♂/♀: SARA, perihepatitis ♂: epididymitis	♀ 1e keus: NAAT Ct diep vaginale uitstrijk (zelfswab) 2e keus: NAAT in eerstestraals urine ♂ NAAT Ct eerstestraals urine of urethra swab Op indicatie: - bij klachten: lichamelijk/ inwendig onderzoek - nav seksuele technieken of klachten elders: uitstrijk van locatie (bijv rectum, conjunctiva) Testen op Ct in de keel wordt afgeraden Anorectale infectie bij MSM en transgender vrouwen: LGV uitsluiten middels NAAT Ct en Ct genotypering	Vaginale en/of urethrale Ct-infecties: doxycycline 100 mg po 2 dd 7 d OF azitromycine 1000 mg po eenmalig Rectale Ct-infecties: - 1e keus: doxycycline 100 mg po 2 dd 7 d - 2e keus: azitromycine 1000 mg po eenmalig Zwangeren met Ct: 1e trimester: azitromycine 1000 mg po eenmalig OF doxycycline 100 mg 2 dd 7 d 2e en 3e trimester: azitromycine 1000 mg po eenmalig	**Controle:** bij aanhoudende klachten en afwijkende therapiekeuze test-of-cure (4 w na afronden behandeling) Bij zwangeren met sterk verhoogde kans op Ct-infectie: na een eerdere (behandelde) Ct-infectie nieuwe test in derde trimester **Partnernotificatie:** (a)symptomatische Ct: alleen huidige sekspartner(s) inlichten en zn meebehandelen Bespreek risico op en belang van voorkomen herinfectie in het bijzonder bij vrouwen in vruchtbare leeftijd, adviseer diagnostiek bij klachten Adviseer 7 d geen seks vanaf start behandeling
Lympho-granuloma venereum (LGV) *1 - 5 w*	Anorectale LGV: proctitis met purulente/bloederige afscheiding, pijn, jeuk, krampen en obstipatie Hoger gelegen infecties (proctocolitis): diarree, koorts, gewichtsverlies Inguinale LGV: pijnlijke, fluctuerende en abcederende lymfeklierzwellingen (bubo's) Complicaties: anale stricturen, fistels, elefantiasis	Indien proctitis en ulcera: weefselbiopten Indien fluctuerende lymfeklieren: aspiratie van pus Andere gevallen: NAAT Ct en Ct genotypering rectale swab Sekspartner(s) ingelicht voor LGV met positieve Ct diagnostiek urethraal/ vaginaal doortesten op LGV	1e keus: doxycycline 100 mg po 2 dd 21 d Alternatief: azitromycine 1000 mg po 1 keer per w 3 w OF erytromycine 500 mg po 4 dd 21 d Bubo's: wekelijks ontlasten middels aspiratie via intacte huid, ná start van de antibiotische behandeling Cave: incisie inguinale bubo's, geeft kans op fisteling	**Controle:** Bij gebruik van alternatieve behandeling: test-of-cure 4 w na afronden behandeling Inguinale LGV: nacontrole aan het einde van de kuur. Zo nodig kuur verlengen obv persisteren-de inflammatoire symptomen **Partnernotificatie:** Symptomatisch (doorgaans proctitis): alle sekspartners tot 4 w voorafgaand aan begin klachten (of langer terug als laatste sekspartner langer terug is) Asymptomatisch: alle sekspartners uit de 3 m vóór het vaststellen van de diagnose Adviseer geen seks tot behandeling is afgerond

Soa & windowfase	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Gonorroe *(Neisseria gonorrhoeae Ng)* *2 d - 3 w* *(bij ♀ zijn asymptomatische, persisterende infecties aangetoond tot 6 m)* Zie MDR voor gonokokken conjunctivitis en gonokokken keratitis	♀: 30-60% asymptomatisch toegenomen fluor, tussentijds bloedverlies, dysurie, faryngitis, proctitis Complicaties: bartholinitis, PID, EUG, infertiliteit ♂: ca.10% asymptomatisch urethritis, branderig gevoel, dysurie, pussende afscheiding (druiper), faryngitis, proctitis Complicaties: epididymitis, prostatitis, bij chronische infectie urethrale stricturen ♀ en ♂: orofaryngeale en anorectale gonorroe meestal asymptomatisch Klachten: irritatie, jeuk, slijmerige afscheiding	- NAAT (zie hieronder) - kweek plus resistentiebepaling - grampreparaat of methyleen-blauwkleuring (♂) ♀: NAAT diep vaginaal (zelfswab) of cervix plus urethra (swab door onderzoeker) 2e keus: NAAT in eerstestraalsurine ♂: NAAT eerstestraalsurine of NAAT van pus uit urethra MSM: routinematig NAAT urethra, orofarynx, rectaal ♀ en ♂: n.a.v. seksuele technieken of klachten elders: uitstrijk van locatie (bv rectum, keel, conjunctiva)	ceftriaxon 500 mg im eenmalig Bij bewezen of klinische verdenking faryngeale infectie: ceftriaxon 1000 mg im eenmalig Alternatief: - cefotaxim 1000 mg im eenmalig - op geleide van gevoeligheidsbepaling (kweek of moleculair): ciprofloxacine 500 mg po eenmalig	**Controle:** test-of-cure (minimaal 1 w na beëindigen behandeling anogenitale Ng / minimaal 2 w na orofaryngeale Ng) - na elke alternatieve behandeling - bij persisterende klachten (plus kweek!) - bij re-expositie - orofaryngeale Ng **Partnernotificatie:** ♂ met symptomatische Ng urethritis: alle seks-partners 2 w voorafgaand aan klachten (of langer terug als laatste sekspartner langer terug is) Bij andere klachten en anatomische locaties: 3 m voorafgaand aan klachten ♂ met asymptomatische Ng en alle ♀♀: alle sekspartners van de laatste 3 m Adviseer na ceftriaxon im 7 dagen geen seks
Vroege syfilis *Treponema Pallidum* Tp (stadium I, II en vroeg latente / latens recens) **Syfilis I**: *10 - 90 d (gemiddeld 3 w)* **Syfilis II**: *4 - 8 (gemiddeld 6) w na syfilis I klachten tot 6 - 12 m na infectie* **Syfilis latens recens**: *seroconversie in laatste 12 m* Zie MDR voor (verdenking van) syfilis bij zwangere vrouwen, kinderen en congenitaal	Altijd lichamelijk onderzoek om stadiëring te bepalen Syfilis I: genitaal, anorectaal of oraal solitair, pijnloos ulcus durum met/zonder necrotisch beslag, met/zonder palpabele lymfadenitis. Ulcus verdwijnt ook zonder behandeling binnen 3-6 w Syfilis II: maculopapuleus, meestal niet jeukend exantheem op romp en extremiteiten (70% op handpalmen en voetzolen), slijmvlies afwijkingen Syfilis latens recens: latente periode binnen 1 j na infectie Complicaties (in het bijzonder bij personen met hiv): neurosyfilis met uveitis en facialis parese, sudden deafness, nefritis en hepatitis	Serologie: TPHA/TPPA of EIA gevolgd door IgG-Westernblot Indien positief: RPR ter bepaling van de activiteit van de infectie Bij verdenking op primaire syfilis ook: - NAAT op Tp (swab van schoon ulcus) - eventueel donkerveldmicroscopie - vervolg serologie na 3, 6 en 12 w vanaf ontstaan van klachten noodzakelijk wanneer geen diagnose met donkerveldmicro--scopie of NAAT gesteld kan worden Cave: bij exantheem, denk ook aan acute hiv-infectie NB: hiv-serologie NB bij alle ingelichte sekspartners lichamelijk onderzoek om stadiëring te bepalen en klachten passend bij neurosyfilis uitvragen	Benzathinebenzylpenicilline 2,4 milj IE im eenmalig (1,2 milj IE oplossen in 2 ml lidocaïne 20mg/ml + 2 ml fysiologisch zout im toedienen in elke bil) OF doxycycline 100 mg po 2 dd 14 d (als alternatieve behandeling bij gedocumenteerde overgevoeligheid voor penicilline, niet bij zwangeren en neurosyfilis) Algemeen advies: overleg laagdrempelig over patiënten met syfilis met een soa-poli of een soa-deskundig dermatoloog NB bij aangetoonde syfilis altijd klachten passend bij neurosyfilis uitvragen	**Controle:** RPR zesmaandelijks gedurende 1 j, tot viervou-dige RPR-titerdaling wordt vastgesteld (mensen met hiv: elke 3 m gedurende 2 j) NB: Bij een titer van < 1:2 op moment van behandeling is follow-up op klinische gronden niet strikt noodzakelijk, maar wel zinvol ter uitsluiting van een nieuwe infectie Verwijs naar neuroloog voor indicatie liquor-onderzoek op neurosyfilis: - wanneer na 12 m (24 m bij mensen met hiv) geen viervoudige RPR-titerdaling is opgetreden en een herinfectie is uitgesloten. - bij neurologische klachten/ afwijkingen tijdens de follow-up **Partnernotificatie:** Syfilis I: alle sekspartners 3 m voorafgaand aan klachten Syfilis II: alle sekspartners 6 m voorafgaand aan klachten. Bij eerdere negatieve syfilistest: alle sekspartners tot 3 m voorafgaand aan laatste negatieve test Syfilis latens recens: alle sekspartners van de afgelopen 12 m. Bij eerdere negatieve syfilis-test: alle sekspartners tot 3 m voorafgaand aan laatste negatieve test Adviseer geen seks tot 7 d na het einde van de behandeling en er een huidlaag gevormd is over het ulcus/klachtenvrij
Syfilis latens van onbepaalde duur (RPR ≥1:8, infectieus) **Syfilis latens tarda (laat latent)** (seroconversie >1 j geleden, niet-infectieus)	Asymptomatische latentieperiode	Serologie: TPHA/TPPA of EIA gevolgd door IgG-westernblot Indien positief: RPR ter bepaling van de activiteit van de infectie Uitsluiten: neurosyfilis en cardiovasculaire syfilis NB: hiv-serologie	benzathinebenzylpenicilline 2,4 milj IE im op dag 1, 8 en 15 OF doxycycline 100 mg po 2 dd 28 d (als alternatieve behandeling bij gedocumenteerde overgevoeligheid voor penicilline, niet bij zwangeren en neurosyfilis) NB bij aangetoonde syfilis altijd klachten passend bij neurosyfilis uitvragen	**Controle:** RPR-controle na 6, 12 en 24 m (bij mensen met hiv: inclusief onderzoek naar klinische verschijnselen passend bij neurosyfilis) Verwijs naar neuroloog - indien na 24 m geen 4-voudige titerdaling is opgetreden en herinfectie is uitgesloten - neurologische klachten/afwijkingen tijdens de follow-up **Partnernotificatie:** syfilis latens onbepaalde duur: alle sekspart-ners van de afgelopen 24 m Adviseer geen seks tot 7 d na einde behandeling Syfilis latens tarda: bij langdurige relatie: licht sekspartner(s) en eventuele kinderen van vrouwelijke indexpatiënten in

Soa & windowfase	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Syfilis III (niet-infectieus) *Incubatietijd: 2 - 30 j na infectie*	2 tot 4 j na infectie kan 'vroege' tertiaire orgaansyfilis ontstaan: tuberculoïde nodeuze of ulcererende afwijkingen in huid, slijmvliezen, botten en vrijwel elk inwendig orgaan (gummata), symptomen zijn afhankelijk van de getroffen organen Cardiovasculaire syfilis (na 20 tot 30 j): aneurysmata aortae, destructie van aortaklep	Als bij syfilis latens tarda	Benzathinebenzylpenicilline 2,4 milj IE im op dag 1, 8 en 15 OF doxycycline 100 mg po 2 dd 28 d (als alternatieve behandeling bij gedocumenteerde overgevoeligheid voor penicilline, NIET bij zwangeren en neurosyfilis) NB bij aangetoonde syfilis altijd klachten passend bij neurosyfilis uitvragen	**Controle:** RPR jarenlang vervolgen Verwijs naar neuroloog om te testen op neurosyfilis (liquoronderzoek) en orgaanafwijkingen voorafgaande aan de behandeling **Partnernotificatie:** als bij syfilis latens tarda
Neurosyfilis (inclusief oculaire syfilis) *Incubatie tijd: enkele m tot vele j na infectie*	Vroege neurosyfilis: hersenzenuw uitval (gehoorverlies, tinnitus, visus stoornissen, faciale paresen), neuropathie, gedragsveranderingen Late neurosyfilis: dementia paralytica, tabes dorsalis, neuropsychiatrische beelden Oculaire syfilis: vooral in secundaire en tertiaire stadium; uveïtis, pijn, roodheid, fotofobie, mouches volantes, visusdaling, fotopsiën	Neurosyfilis: liquor onderzoek op TPHA/TPPA, RPR, leukocyten (celgetal), totaal eiwit. RPR is de standaardtest. Om contaminatie uit te sluiten wordt aangeraden om erytrocyten in de liquor te bepalen (zie MDR) Oculaire syfilis: zoals neurosyfilis op indicatie voorste oogkamerpunctie met oa NAAT Tp	Klinisch: kortwerkend benzylpenicilline iv 6 dd 3-4 milj IE of continue infusie gedurende 10-14 d - mogelijk IgE-gemedieerde penicilline-allergie: overweeg penicilline-desensibilisatie gevolgd door behandeling met kortwerkend benzylpenicilline iv - niet IgE-gemedieerde allergie: ceftriaxon 2 gr iv gedurende 14 d Een alternatief dat poliklinisch gegeven kan worden is ceftriaxon 2 gr iv 1 dd 14 d oculaire syfilis: via oogarts, zie MDR	**Controle:** RPR zesmaandelijks tot viervoudige RPR-titerdaling in het serum Verwijs naar neuroloog voor liquorpunctie: indien na 12 m geen viervoudige daling in serum NB: Routinematig liquoronderzoek 6 m na behandeling van neurosyfilis alleen geïndiceerd bij mensen met hiv met een slechte afweer (CD4 < 350 cellen/mm³) **Partnernotificatie:** afhankelijk van stadium
Hepatitis A ◊ (meldingsplichtig) *Incubatietijd: 14 - 50 d (gemiddeld 28 d)*	75% van volwassenen acuut beeld met malaise, koorts, buikklachten en geelzucht gedurende 1 - 2 w	NAAT HAV-RNA op bloed of feces 2 w voor tot 4 w na de 1e ziektedag HAV-specifieke IgM-antistoffen in serum, vaak al aantoonbaar vóór 1e ziektedag t/m maanden erna	Symptomatisch behandeling van symptomen Bij ernstig beloop: verwijzing internist-/kinderarts-infectioloog of MDL-arts Preventie voor personen met een verhoogde kans op HAV middels vaccinatie, ook verkrijgbaar in combinatie met HBV	**Controle:** melding aan afdeling IZB GGD (meldingsplicht binnen 1 werkdag), daar advies tav preventie, BCO, testen en vaccinatie risicocontacten **Partnernotificatie (door GGD):** sekspartners tot 6 w voor diagnose
Hepatitis B ◊ (meldingsplichtig) *Incubatietijd: 4 w - 6 m (meestal 2 - 3 m)* Vaccinatie (via CSG) adviseren aan: -MSM -personen die seks hebben voor geld -sekspartners en huisgenoten van HbsAg-positieve personen (dragers) - iv drugsgebruikers (via verslavings zorg)	Vaak asymptomatisch of aspecifiek (koorts, moe, 'griep') in de acute fase	anti-HBc, indien positief: HBsAg, anti-HBs, HbeAg en anti-Hbe PM bij immunosuppressie overleg met arts-microbioloog voor aanvullende diagnostiek	Bij een verdenking op een actieve vorm van chronische hepatitis B verwijzen naar de MDL-arts voor indicatie en keuze behandeling	**Controle:** melding aan afdeling IZB GGD (binnen 1 werkdag), daar advies tav preventie, BCO, testen en vaccinatie risicocontacten **Partnernotificatie (door GGD):** acute HBV: sekspartners laatste 6 m chronische HBV: tot minstens 1 j terug
Hepatitis C ◊ (meldingsplichtig) *gemiddeld 7 w (2 - 26 w)* *Windowfase anti-HCV (indien hiv negatief): >90% binnen 3 m* *Windowfase HCV-RNA: 7-10 d* *NB: bij mensen met hiv kan de windowfase verlengd zijn*	Als soa met name onder MSM met hiv of die PrEP gebruiken 20% ervaart klachten: koorts, vermoeidheid, misselijkheid of geelzucht	Bij verdenking chronische HCV-infectie: anti-HCV en confirmatie indien niet eerder bekend. Bij recent seksueel contact (met hoge kans) met positieve partner, bij partnernotificatie en om actieve infectie uit te sluiten: HCV-RNA en anti-HCV PM bij immunosuppressie en/of hiv overleg met arts-microbioloog voor aanvullende diagnostiek	Indien anti-HCV en confirmatie positief, verricht een HCV-RNA om persisterende infectie vast te stellen Indien positief, verwijs naar internist/hepatoloog	**Controle:** melding aan afdeling IZB GGD, daar advies tav preventie, BCO en testen risicocontacten **Partnernotificatie: (door GGD)** -met klachten: sekspartners met wie anale seks (penetratie) is gedaan of met wie naalden/drugsrietjes zijn gedeeld tot 3 m voorafgaand aan klachten -zonder klachten: sekspartners met wie anale seks (penetratie) is gedaan of met wie naalden/drugsrietjes zijn gedeeld tot 3 m voor laatste negatieve test, indien nooit of lang geleden getest: tenminste minimaal 1 j terug

Soa & windowfase	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Hiv ◊ Seroconversie zelden na 3 m, veelal seroconvesie binnen 45 d, P24-antigen aantoonbaar vanaf 15 d na infectie Bij elke hiv-diagnose (ook sneltest) navragen of er seksueel contact <72 u is geweest Bij mogelijke overdracht van hiv: PEP adviseren aan deze seks-partner(s)	Acute hiv/ acuut retroviraal syndroom (bij 50-90%): koorts, vermoeidheid, spierpijn, huiduitslag, hoofdpijn, keelontsteking, cervicale lymfadenopathie, gewrichtspijn, nachtzweten en diarree AIDS: opportunistische infecties, neurologische ziektebeelden en neoplasieën	Testen en betrouwbaarheid op basis van windowfase vanaf laatste mogelijke expositie: - Derdegeneratie-hiv-sneltest: na 2 tot 3 m, afhankelijk van soort sneltest -Vierdegeneratie-hiv-combotest (ELISA): vanaf ~2 w aantoonbaar; 99% na 6 w; uitsluiten na 12 w -Hiv-1-RNA-test: vanaf 1-2 w aantoonbaar; betrouwbaar indien klachten van acute hiv-infectie NB gebruik van antiretrovirale therapie (bijvoorbeeld PrEP of PEP) kan seroconversie vertragen en windowfases verlengen: overleg met arts-microbioloog!	Antiretrovirale behandeling door hiv-behandelcentrum Preventie voor personen met een verhoogde kans hiv op te lopen middels pre-expositie profylaxe (PrEP)	**Controle:** via hiv-behandelcentrum **Partnernotificatie:** Bij eerdere negatieve hivtest: alle sekspartners tot 3 m voorafgaande aan die test Zonder eerdere negatieve hivtest: huidige seks-partner(s) en partners van minstens 1 j terug Bij klachten acuut retroviraal syndroom kan deze periode ingekort worden tot 3 m Ingelichte sekspartners: vraag klachten passend bij acuut retroviraal syndroom, adviseer com-botest bij deze klachten, hertest 3 - 4 w en 3 m na laatste contact Adviseer seks met condoom met losse en vaste sekspartner(s) tot virusonderdrukking is bereikt
Herpes genitalis (HSV) *2 - 12 d* Zie MDR voor HSV in zwanger-schap, bij neonaat of immuun-gecompromitteer-den	Vaak asymptomatisch blaasjes met helder vocht, pijnlijke erosies, soms met korstvor-ming en pussig beslag Primo-infectie meestal heftiger dan reactivatie Prodromale verschijnselen: koorts, malaise, spierpijn, lokale pijn, jeuk, dysurie, vaginale afscheiding, urethritis en regionale lymfadenopathie Regelmatige reactivatie gedurende vele jaren is mogelijk	NAAT HSV1/2 op materiaal uit blaas/erosie HSV-type specifieke serologie kent in de dagelijkse praktijk weinig toepassingen (zie MDR) DD syfilis, LGV, chancroïd en granuloma inguinale (verwijzing soa-deskundig dermatoloog)	Primaire infecties immuuncompetente volwassenen: nucleoside analogon, bijv.: valaciclovir 500 mg po 2 dd 5d OF aciclovir 400 mg po 3 dd 5 d OF famciclovir 250 mg 3 dd 5 d Primaire infectie immuungecompromitteerde volwassenen: valaciclovir 1000 mg po 2 dd 10 d of tot re-epithelialisatie laesies OF aciclovir 800 mg po 3 dd 10 d of tot re-epithelialisatie laesies OF famciclovir 500 mg po 3 dd 10 d of tot re-epithelialsiatie laesies Recidieven: indrogende therapie (bijv. zinkoxide 10% of zinksulfaat 0,5% vaselinecrème) OF nucleoside analogon, start <48 u bij prodro-male verschijnselen Frequente recidieven: overweeg korte kuur Zeer frequente recidieven (>6 / j): overweeg onderhoudsmedicatie	**Controle:** indien complicaties of ernstig verloop wordt gevreesd, bijvoorbeeld vanwege een onderliggend lijden **Partnernotificatie:** niet zinvol, het inlichten van vaste sekspartners wel Het feit dat herpes vaak overgedragen wordt door asymptomatische dragers maakt effectieve preventie bijzonder lastig Adviseer geen seks bij zichtbare laesies
Condylomata acuminata (HPV) *1 - 8 m* *gemiddeld 3 m*	Wratten met bloemkoolachtige structuur, soms keratotisch oppervlak Soms jeuk, pijn, brandend gevoel of afscheiding	Diagnose obv kliniek. Het is niet gebruikelijk om een biopt te nemen voor histologisch en HPV-onderzoek NAAT HPV draagt niet bij aan diagnostiek of behandelbeleid Histologisch onderzoek kan worden overwogen bij: - lang bestaande, therapieresistente anogenitale wratten - twijfel over eventuele (pre-) maligne laesies - immuungecompromitteerde patiënten Soa-diagnostiek op indicatie Bij klachten of verdenking van lokalisatie op inwendige plaatsen (afhankelijk van locatie): speculumonderzoek, urethroscopie (uroloog) en/of proctoscopie (dermatoloog/GGD arts)	podofyllotoxine (crème 0,15%, vloeistof 0,5%): 2 dd gedurende 3 achtereenvolgende d per w, max 5 w OF imiquimod (crème 5%): driemaal per w, om de dag, max 16 opeenvolgende w OF sinecathechine (zalf 10%) 3 dd max 16 opeenvolgende w Zie MDR voor overige behandelingen en indicaties voor specialistische verwijzing	**Controle:** routinematige nacontrole is medisch niet noodzakelijk bij standaardbehandeling **Partnernotificatie:** niet zinvol, het inlichten van vaste seks-partners wel Het feit dat HPV vaak overgedragen wordt door asymptomatische dragers maakt effectieve preventie bijzonder lastig
Mycoplasma genitalium (Mg) *14 d (expert opinion)*	Mg is geassocieerd met niet-gonorroïsche urethritis (NGU) bij mannen Er is onvoldoende bewijs voor associatie met fluorklachten, PID, epididymitis, infertiliteit en overige complicaties	Test personen met een penis met >4 w persisterende of recidiverende urethritis, bij wie chlamydia en gonorroe zijn uitgesloten of die reeds behandeld zijn, op Mg: NAAT (eerstestraalsurine, vaginale swab) Voer bij aantonen van Mg bij voor-keur altijd een resistentiebepaling uit	Indien er geen resistentietypering is gedaan of wanneer er geen sprake is van MRAM: azitromycine 500 mg po op dag 1, dag 2-5 250 mg po 1 dd Bij aanhoudende klachten na eerdere behandeling met azitromycine OF bij aantonen MRAM bij resistentietypering: moxifloxacine 400 mg po 1 dd 7 - 10 d	**Controle:** niet nodig. Bij aanhoudende klachten ondanks behandeling: overweeg verwijzing uroloog **Partnernotificatie:** huidige sekspartner(s) van persoon met penis met persisterende urethritis: inlichten en testen Adviseer geen seks tot 7 d na begin van behandeling

Soa & windowfase	Symptomatologie	Diagnostiek	Behandeling	Controle en partnernotificatie
Pediculosis pubis ◊ *Onbekend, minimaal 5 d*	Jeuk, parasiet zichtbaar op huid schaamstreek, neten (eieren) zichtbaar geklit aan haarschacht	Klinisch beeld Directe microscopie (kleine vergroting)	Permetrine 5% crème, gedurende 10 uur, daarna uitwassen OF Ivermectine 250 µg/kg oraal Herhaal behandeling 7 – 10 d later Hygiënemaatregelen: dagelijks luizen en neten verwijderen tot einde behandeling, scheren, kleding, beddengoed en handdoeken van laatste 3 d wassen >50 gr gedurende tenminste 30 min	**Controle:** niet nodig **Partnernotificatie:** alle sekspartners 3 m terug informeren, huidige sekspartner(s) en huisgenoten meebehandelen Adviseer geen seks tot 7 d na afronden laatste behandeling
Mpox (meldingsplichtig) *gemiddeld 6-13 d* Zie voor het actuele advies de LCI-richtlijn Mpox	Prodromale atypische klachten zoals malaise, koorts, hoofdpijn, spierpijn en lymfadenopathie Huidafwijkingen kunnen ook het eerste symptoom zijn, daarna ontstaan (meestal binnen 7 d) maculopapuleuze huidafwijkingen die evolueren in de loop van d tot w naar vesikels of pustels (vaak pijnlijk) Alleen rash is mogelijk. Daarnaast kunnen proctitis klachten ontstaan (afhankelijk van plaatst van inoculatie)	NAAT op MPXV - Bij patiënten <u>met</u> huidlaesies: blaasjeswat van een huidlaesie, bij voorkeur van een vochtige laesie als deze aanwezig is. Daarnaast: anuswat, (optioneel) keelwat - Bij patiënten <u>zonder</u> huidlaesies anuswat EN een keelwat	Symptomatisch, bij ernstige gevallen tecovirimat via academisch ziekenhuis	**Controle:** melding aan afdeling IZB GGD, daar advies tav preventie en BCO **Partnernotificatie:** (door GGD) alle sekspartners sinds begin van systemische klachten en 2 d voor ontstaan huidlaesies, bij klachten diagnostiek inzetten Hoog risicocontacten en een deel van de matig risicocontacten komen in aanmerking voor post-expositieprofylaxe middels vaccinatie Vaccinatie wordt bij voorkeur binnen 4 d, tot uiterlijk 14 d na blootstelling gegeven Indien er sprake is van mpox en ziekenhuisopname niet noodzakelijk: adviseer zelfisolatie Adviseer geen seks tot alle huidlaesies geëpithelialiseerd zijn (waarbij korstjes van de huid vallen) en andere klachten zijn verdwenen Tevens: condoomgebruik (personen met penis) tot 12 w na verdwijnen van laatste laesie
Scabiës ◊ *2-6 w* *herinfectie 1-4 d* NB: Bij grotere groepen, betrokkenheid van instellingen en bij scabiës crustosa: schakel afdeling IZB van de GGD in Zie voor het actuele advies de LCI-richtlijn Scabiës	Erythemato-squameuze uitslag, gangetjes interdigitaal en rond de tepels bij vrouw of penis en scrotum bij man (niet obligaat). In de tijd toenemende jeuk op plekken waar mijten zitten, en secundair gegeneraliseerde jeuk Cave scabiës crustosa: hyperkeratose, papels, noduli Ernstige infestatie: hoge besmettelijkheid	Over het algemeen op basis van klinisch beeld Dermatoscopie en microscopisch onderzoek (KOH-preparaat) Zie MDR voor overige diagnostische methodes	Zie voor het actuele advies de LCI-richtlijn Scabiës	Zie voor het actuele advies de LCI-richtlijn Scabiës

Partnernotificatie en meebehandeling: voor verdieping zie tekst of app MDR soa en draaiboek Partnermanagement RIVM.
Seksueel misbruik (met name bij kinderen) en acute zorg na seksaccident: zie tekst MDR soa en draaiboek Seksaccidenten RIVM.
Handvatten voor gespreksvoering in het soa consult: zie tekst MDR soa.

◊ Vanwege relevantie voor soa-bestrijding toegevoegd, gebaseerd op LCI-richtlijn, niet behandeld in tekst MDR.
Dit overzicht is gebaseerd op HJC de Vries, AP van Dam et al. Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

2022-2024 www.nvdv.nl

NVDV NVMM SOAIDS Nederland